HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Признаки вялого пищеварения

и почему они возникают

О чём этот урок

Разбираем **признаки вялого пищеварения**: почему возникают жалобы, что за ними стоит, какие состояния и диагнозы. Сначала — **причины формирования** вялого типа, затем — **что означают жалобы** по отделам ЖКТ.

Вялое пищеварение — не официальный диагноз, а собирательный термин: снижение активности пищеварительной системы. В восточной медицине есть понятие **«пищеварительный огонь»** — совокупность нормальных процессов в органах ЖКТ. При вялом пищеварении этот огонь снижен, «гаснет».

1. Причины формирования вялого типа пищеварения

№	Причина	Почему это влияет
1	**Хронический стресс, переутомление, нарушение режима** (недостаток сна, позднее засыпание)	Влияют на нервную систему, а она управляет органами ЖКТ (см. урок о нервной системе и ЖКТ)
2	**Сидячий образ жизни, гиподинамия, нарушение осанки**	При движении — даже бытовом — мышцы пресса массируют и стимулируют органы ЖКТ (они тоже мышечные структуры). Мало движения → атония, низкий тонус пищеварительной трубки. Сидя «скрючившись», мы не расправляем диафрагму — затрудняются отток желчи, перистальтика и моторика желудка
3	**В питании:** избыток холодной пищи, сладкого, тяжёлого, мучного, крахмалистого, обволакивающего	Затрудняют моторику ЖКТ и снижают выработку ферментов
4	**Строгие диеты** → дефициты витаминов группы В (особенно В1), магния, железа, цинка	Эти вещества входят в состав ферментов, участвуют в моторике и восстановлении слизистых. Их много в крупах и бобовых — а они первыми идут «под нож» на диете
5	**Мало жиров, клетчатки, горечей, кислого вкуса, ферментированных продуктов, экстрактивных веществ**	Это естественные стимуляторы ЖКТ: запускают моторику, усиливают секрецию соков. Когда еда пресная и безвкусная, «желудок грустит»

№	Причина	Почему это влияет
6	**Привычки:** регулярное переедание, еда на ночь, лежать и мало двигаться после еды, купание в холодной воде	Переедание — не хватает ферментов и соков на объём. В расслабленном лежачем состоянии снижается моторика, пища дольше задерживается в желудке и кишечнике. Холодная вода тормозит ЖКТ
7	**Длительные хронические воспалительные процессы ЖКТ** (гастриты разных типов и др.)	Любое хроническое воспаление истощает органы ЖКТ. Поэтому у людей с многолетними диагнозами часто смешанный тип: воспалённый + много признаков вялого
8	**Бариатрическая операция** (удаление части желудка)	Аппетит и вес снижаются, но появляется «супервялое» пищеварение: переваривается только крошечный объём, малейший избыток жиров или белка вызывает тошноту, вздутие, рвоту
9	**Вторичные причины:** гипофункция щитовидной железы (гипотиреоз), депрессия, вегетативная дисфункция, неврозы, сахарный диабет 2-го типа	Эти состояния угнетают работу ЖКТ. Стимулировать ЖКТ можно и нужно, но обязательно работать и с первичной причиной вне ЖКТ
10	**Приём лекарств:** антациды, ингибиторы протонной помпы (ИПП), антидепрессанты, бета-блокаторы и др.	Угнетают работу ЖКТ, особенно при длительном или бесконтрольном приёме. Принимать только по назначению и под контролем врача
11	**Старение**	С возрастом активность пищеварения снижается у всех; поддержать ЖКТ помогают питание, специи, травы, правила питания
12	**Конституция с преобладанием доши Слизь / Капха**	Капха опирается на желудок и поджелудочную — сначала увеличивается именно там, поэтому болезни Капхи начинаются с вялого пищеварения

Важно: вялое пищеварение обычно формирует **совокупность факторов**. Одной причины редко хватает — разве что бариатрическая операция или длительное хроническое воспаление, и даже это можно компенсировать.

Домашнее задание. Подумайте, какие факторы в питании и образе жизни сформировали вялый тип пищеварения у вас. Напишите в комментариях к уроку — обсудим.

2. Что означают ваши жалобы

Чем лучше мы понимаем, откуда берутся жалобы, тем продуктивнее избавляемся от них. Как исправлять — в следующих уроках.

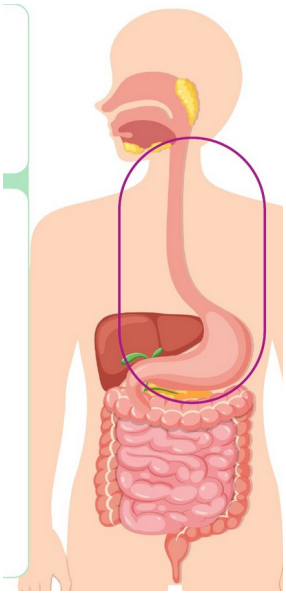
2.1. Язык



Слева — отпечатки зубов по краям языка; справа — белый налёт

Признак	Что означает
Тонкий белый налёт, равномерно покрывающий язык	«Фирменный» признак вялого пищеварения — замедленное переваривание пищи в ЖКТ. Более густой налёт может указывать на нарушение микробиома ЖКТ и полости рта (дисбиоз)
Отпечатки зубов по краям языка (могут выглядеть как «волна»)	В классическом подходе — признак гипотиреоза. В восточной медицине — ферментная система, включая поджелудочную, не справляется: формируются пищевые отёки, отёкший язык не помещается во рту

2.2. Желудок



Область желудка — от **мечевидного отростка** (под грудиной, где заканчиваются рёбра) до пупка.

Тяжесть после еды, ощущение медленного переваривания, переполненность желудка

Что происходит: замедленная эвакуация пищи из желудка в 12-перстную кишку. Нарушена моторика — желудок плохо растягивается, сокращается, перемешивает пищу; клетки «филонят» выделять соляную кислоту и ферменты. Пока пища не переработана, дальше она не продвигается. В норме еда находится в желудке от 20 минут до 4 часов, при вялом пищеварении — 5, 6 и до 10 часов. Характерный признак **сниженной кислотности**.

Возможные диагнозы: функциональная диспепсия (слизистая не изменена, но желудок работает плохо); гастриты различного типа, прежде всего атрофический (нарушение трофики, моторики и секреции); гастропарез — замедленное опорожнение желудка.

Частая отрыжка

Что происходит: не смыкается («зияет») нижний пищеводный сфинктер — между желудком и пищеводом, и заглоченный при еде воздух выходит обратно. Причины: частое вздутие повышает внутрибрюшное давление и давит на сфинктеры; медленная эвакуация пищи; сниженная кислотность.

Возможные диагнозы: иногда ставят ГЭРБ.

Изжога после мучного, сладкого, крахмалистого, обильной жирной и белковой пищи

Что происходит: те же причины — несмыкание сфинктера и рефлюкс желудочного содержимого в пищевод. Именно эти продукты дополнительно тормозят переваривание в желудке, который и так работает медленно.

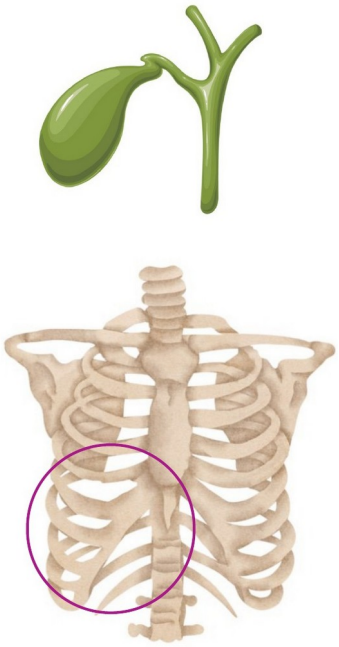
Возможные диагнозы: ГЭРБ, пониженная кислотность, гастропарез.

Слабые тянущие или ноющие боли в области желудка

Что происходит: не острые, не кинжальные, часто после еды. Смешанный признак с чувствительным типом.

Возможные диагнозы: функциональная диспепсия с гиперчувствительностью.

2.3. Правое подреберье — жёлчный пузырь и желчевыводящие пути



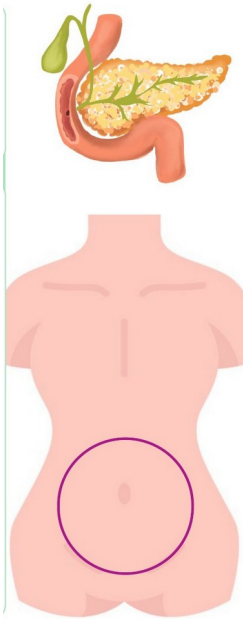
Слабые тупые боли в правом подреберье

Что происходит: нарушен отток желчи при сниженной двигательной активности жёлчного пузыря. Печень производит желчь, она поступает в пузырь, но в ответ на еду пузырь «ленится» её выбросить. Желчь накапливается и растягивает стенки — это и ощущается как слабая тупая боль.

Возможные диагнозы: дискинезия желчевыводящих путей, гипокинетическая форма; сладж (застой, густая «замазкообразная» желчь); хронический холецистит без камней.

Риск: формирование камней жёлчного пузыря — над этим обязательно нужно работать, чем мы и занимаемся на программе.

2.4. Область вокруг пупка — тонкая кишка

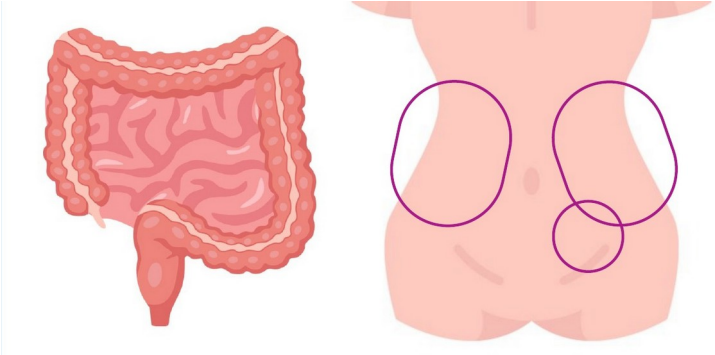


Вздутие вскоре после еды (через 30–60 минут)

Что происходит: особенно на смешанную пищу, обильную трапезу, прохладные напитки, жирное и белковое. В 12-перстной кишке — главном месте переваривания — сходятся ферменты поджелудочной, желчь и ферменты кишечника. При вялом пищеварении их выделяется недостаточно, а смешанная обильная еда и холодное ещё сильнее тормозят процесс. Вздутие — сигнал плохого переваривания.

Возможные диагнозы: нарушение желчеоттока; снижение функции поджелудочной (хронический панкреатит, структурные, диффузные изменения, липоматоз); врождённые или приобретённые дефекты синтеза кишечных ферментов; пищевые непереносимости (например, плохое переваривание молочного).

2.5. Толстая кишка



Регулярное вздутие во второй половине дня (ближе к 16:00)

Что происходит: смешанный признак с чувствительным типом. К этому времени еда, съеденная за завтраком и обедом, подходит к толстой кишке. При нарушении моторики, гиперчувствительности кишечника, дисбиозе клетчатка плохо перерабатывается — отсюда вздутие.

Возможные диагнозы: синдром раздражённого кишечника (СРК), дисбиоз.

Запоры: атонический и спастический

При вялом пищеварении бывают оба типа или их сочетание у одного человека. Как определить свой тип — утром, ещё лёжа в постели, мягко прощупайте живот:

Атонический запор	Спастический запор
✔️ в правом боку (восходящая ободочная кишка) прощупывается «что-то лишнее» — там скапливается содержимое	✔️ дискомфорт при мягкой пальпации слева — левый бок или левый нижний квадрант над подвздошной костью (нисходящая ободочная, сигмовидная кишка); что-то мягко перекатывается под пальцами
✔️ стул раз в 2–3 дня, в тяжёлых случаях — раз в неделю	✔️ стул примерно через день, «как у козочки» — мелкими катышками

Что означают: нарушение моторики кишечника и, возможно, микробиома. Запоры — комплексная проблема: недостаток клетчатки, жидкости, жиров, ферментированных продуктов, нарушение тока желчи, стресс, гиподинамия. Отдельный урок о запорах — в курсе.

Диарея, несформированный стул

Что происходит: при вялом типе — **недостаток ферментов тонкой кишки и поджелудочной железы**. При других типах причины другие.

Газообразование от клетчатки (много зелени, сырой капусты, яблок)

Что происходит: признак чувствительного типа, частый в смешанных ситуациях. Клетчатка перерабатывается в толстой кишке; газы — если не хватает ферментов, микробиом «ленится» (дисбиоз) или съели слишком много. ЖКТ нужно приучать к грубой клетчатке постепенно.

Возможные диагнозы: чувствительный тип / СРК, нарушение микробиома, гиперчувствительность кишечника.

2.6. Тошнота

Тошнота на жирную или белковую пищу

Что происходит: жиры замедляют сокращения желудка, а белок при вялом пищеварении трудно переваривается — и без того медленная эвакуация ещё замедляется. Также возможно плохое переваривание жиров при недостатке ферментов поджелудочной и кишечника или дискинезии желчевыводящих путей, плохое переваривание белков из-за нарушения работы желудка.

Возможные диагнозы: медленная эвакуация пищи, гастропарез.

Тошнота от голода или стресса

Что происходит: признак чувствительного типа — смешанная ситуация «вялое + чувствительное». Указывает на нарушение регуляции ЖКТ со стороны нервной системы (нейрогастроэнтерологические нарушения). Работать нужно с нервной системой — через образ жизни, питание и т. д.

3. Шпаргалка: жалоба → что за ней стоит

Жалоба	Возможная причина
Тонкий белый налёт на языке	Замедленное переваривание; густой — дисбиоз
Отпечатки зубов на языке	Отёчность: сниженная функция поджелудочной и щитовидной желёз
Тяжесть, переполненность, медленное переваривание	Замедленная эвакуация, пониженная кислотность; диспепсия, атрофический гастрит, гастропарез
Отрыжка	Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера; ГЭРБ
Изжога после мучного, сладкого, крахмалистого	Рефлюкс; ГЭРБ, пониженная кислотность, гастропарез

Жалоба	Возможная причина
Слабые ноющие боли в желудке	Функциональная диспепсия с гиперчувствительностью
Слабые тупые боли в правом подреберье	Гипокинетическая дискинезия ЖВП, сладж, холецистит без камней
Вздутие через 30–60 минут после еды	Недостаток ферментов поджелудочной и кишечника, желчи; непереносимости
Вздутие во второй половине дня	СРК, дисбиоз
Запор (атонический / спастический)	Нарушение моторики и микробиома, образ жизни и питание
Диарея, несформированный стул	Недостаток ферментов тонкой кишки и поджелудочной
Газы от клетчатки	Чувствительный тип / СРК, дисбиоз, избыток грубой клетчатки
Тошнота на жирное / белковое	Медленная эвакуация, недостаток ферментов, дискинезия ЖВП
Тошнота от голода или стресса	Нейрогастроэнтерологические нарушения

Вопросы для самопроверки

1. Что такое вялое пищеварение и что в восточной медицине называют «пищеварительным огнём»?
2. Как хронический стресс и нарушение режима приводят к вялому пищеварению?
3. Почему сидячий образ жизни и нарушение осанки снижают работу ЖКТ?
4. Какие особенности питания и пищевые привычки формируют вялый тип?
5. Почему строгие диеты приводят к вялому пищеварению? Дефициты каких веществ здесь важны?
6. Какие вкусы и продукты естественно стимулируют работу ЖКТ?
7. Почему длительное хроническое воспаление и бариатрическая операция приводят к вялому пищеварению?
8. Какие вторичные причины и лекарства могут угнетать ЖКТ? Что важно при вторичном вялом пищеварении?
9. Что означают тонкий белый налёт и отпечатки зубов на языке?
10. Почему при вялом пищеварении возникают тяжесть и переполненность желудка? Сколько времени пища находится в желудке в норме?
11. Каковы причины частой отрыжки и изжоги после мучного и сладкого?

12. Откуда берутся слабые тупые боли в правом подреберье и какие диагнозы за ними стоят?
13. Почему вздутие возникает через 30–60 минут после еды?
14. Как отличить атонический запор от спастического?
15. Почему при вялом пищеварении может быть диарея?
16. Что означает газообразование от клетчатки и вздутие во второй половине дня?
17. Почему возникает тошнота на жирное и белковое? Что означает тошнота от голода или стресса?